

AAMIA · RESUMEN TEMÁTICO 1 DE 5

Salud integral y seguridad clínica

Valoración, cambios relevantes, medicamentos y coordinación del cuidado

valoración integral	fragilidad	medicamentos
---------------------	------------	--------------

Audiencia: Familias, personas cuidadoras y equipos de apoyo

Uso responsable

Este documento organiza y resume una biblioteca local. No diagnostica, no prescribe y no sustituye una valoración profesional. Las fuentes originales son la evidencia canónica; las referencias usan la página física del PDF.

Edición 1.0 · Julio de 2026 · Proyecto AAMIA

Cómo usar este resumen

Está diseñado para recuperación aumentada: cada apartado concentra una intención de búsqueda y conserva referencias legibles. Para decisiones importantes se consulta la fuente original y al equipo profesional.

Campo	Valor
Tema principal	Salud integral y seguridad clínica
Temas de recuperación	valoración integral, fragilidad, medicamentos, polifarmacia, señales de alarma, enfermedad crónica
Tipo de fuente	Resumen secundario; remite a evidencia original
Riesgo clínico	Mixto: educativo con señales de consulta y urgencia
Contexto Markdown	Usado para redactar; no es documento indexado

Principios de síntesis

- Comparar con el estado habitual es más útil que atribuir cualquier cambio a la edad.
- Función, memoria, ánimo, nutrición y red de apoyo forman parte de una misma valoración.
- La familia observa y registra; el personal de salud diagnostica, prescribe y modifica tratamientos.
- Un cambio súbito exige más atención que una dificultad estable y conocida.

Jerarquía de uso

1) localizar el tema; 2) recuperar los fragmentos originales; 3) responder indicando documento y página; 4) reconocer cuando la biblioteca no basta.

1. Partir de una línea de base personal

Una valoración útil comienza por conocer qué puede y quiere hacer la persona, cómo se comunica y qué apoyos utiliza. La autonomía no se mide solo por diagnósticos.

- Registrar capacidad para comer, bañarse, vestirse, usar el baño, desplazarse y manejar compras, citas, medicamentos o finanzas.
- Observar orientación, memoria, atención, ánimo, sueño, dolor, respiración, apetito, evacuaciones y marcha.
- Identificar lentes, auxiliares auditivos, prótesis, bastón o andadera y comprobar que funcionen.
- Anotar preferencias, rutinas, alergias, diagnósticos, contactos y decisiones anticipadas expresadas.

Síntesis de [R1, pp. 2 y 7], [R2, pp. 11 y 123-124], [R3, pp. 10-11] y [R4, pp. 19 y 22-25].

2. Envejecimiento no significa enfermedad

El envejecimiento modifica la reserva de distintos sistemas, pero no vuelve normal la pérdida rápida de capacidad ni explica por sí solo síntomas nuevos.

- Distinguir cambios graduales de deterioro repentino. Confusión nueva, debilidad súbita, caída reciente o somnolencia inusual requieren valoración.
- La fragilidad puede expresarse como menor fuerza, lentitud, cansancio, pérdida de peso o menor tolerancia al esfuerzo.
- Factores físicos, cognitivos, emocionales, nutricionales y sociales pueden interactuar.
- Evitar estereotipos: edad cronológica o número de enfermedades no determinan por sí solos capacidad y preferencias.

Reserva fisiológica, sarcopenia y fragilidad se revisan en [R5, pp. 5 y 7] y [R6, pp. 1 y 4].

3. Observar, registrar y comunicar

Un registro breve permite detectar tendencias y comunicar hechos concretos al equipo tratante.

- Anotar fecha, hora, qué cambió, actividad previa, duración, síntomas asociados y recuperación.
- Registrar caídas, dosis omitidas, dificultad para tragar, rechazo de alimentos, menos orina, fiebre, dolor o cambios conductuales.
- Preparar preguntas antes de cada consulta y llevar registros y lista de medicamentos.
- Compartir información entre cuidadores para evitar versiones contradictorias o pérdidas de seguimiento.

Observación del cuidador en [R1, pp. 2-3 y 7], [R2, p. 50] y [R3, pp. 11 y 25].

4. Medicamentos sin improvisar

La polifarmacia aumenta complejidad, interacciones y reacciones adversas. La respuesta segura es revisar, no suspender por cuenta propia.

- Mantener una lista única con nombre, dosis, horario, motivo e indicación profesional; incluir productos sin receta y herbolaria.
- Usar un solo sistema de organización. No duplicar una dosis olvidada sin instrucciones específicas.
- No triturar tabletas ni abrir cápsulas sin confirmar que sea seguro.
- Solicitar revisión ante mareo, somnolencia, confusión, estreñimiento, sangrado, caídas o dificultad para cumplir el esquema.

Recomendaciones convergentes en [R1, p. 7], [R2, p. 50], [R3, p. 25] y [R7, pp. 2 y 5].

5. Enfermedades crónicas y transiciones

Cuando existen varias enfermedades, el plan debe coordinar función, prioridades y carga del tratamiento.

- Conservar un resumen de diagnósticos, medicamentos, alergias, contactos y cambios recientes.
- Tras una hospitalización, confirmar por escrito cambios en medicación, alimentación, movilidad, curaciones y seguimiento.
- Prevenir inmovilidad innecesaria durante la recuperación siguiendo las indicaciones del equipo tratante.
- Las decisiones complejas deben considerar beneficios, riesgos, calidad de vida y preferencias expresadas.

Coordinación de patología crónica en [R8, pp. 1-2]; transiciones y riesgos en [R2, pp. 123-124] y [R9, pp. 4-5].

6. Evidencia especializada: límites

Los artículos sobre terapia intensiva, cirugía, estenosis aórtica y demencia avanzada ayudan a reconocer complejidad, pero no deben convertirse en instrucciones domésticas.

- Usar estas fuentes para formular preguntas, no para elegir procedimientos o tratamientos.
- Varios artículos clínicos son de 2012 y pueden no reflejar guías actuales.
- Ante contradicciones, priorizar al equipo tratante y fuentes institucionales recientes aplicables al país y condición.
- Mantener separadas la educación general y la decisión clínica individual.

Contexto especializado: [R9], [R10], [R11] y [R12]. La epidemiología [R13] no genera recomendaciones individuales.

Orientación por nivel de acción

Esta tabla no es un sistema de triaje. Resume una respuesta conservadora a cambios comunes y señales de peligro.

Nivel	Situación	Acción
Observar	Cambio leve, estable o aislado sin señales de alarma.	Registrar y comentar en el seguimiento.
Consultar pronto	Deterioro nuevo de memoria, marcha, apetito, ánimo, continencia o capacidad diaria.	Contactar salud y llevar cronología y medicamentos.
Atención urgente	Pérdida de conciencia, dificultad intensa para respirar, dolor torácico, sangrado que no cede, rostro caído, debilidad de un brazo, habla alterada o deterioro rápido.	Contactar emergencias locales; no esperar a la aplicación.

Regla de seguridad

Cuando el cambio es súbito, intenso, empeora rápido o la persona no puede mantenerse a salvo, se prioriza ayuda humana inmediata sobre la consulta al RAG.

Qué debe conservar una respuesta de AAMIA

- Diferenciar educación general de indicaciones personalizadas.
- Mostrar fuentes originales y páginas que sostienen la respuesta.
- Declarar incertidumbre, antigüedad o desacuerdo entre fuentes.
- No transformar procedimientos clínicos en instrucciones domésticas.
- Recordar que autonomía, preferencias y contexto importan.

Fuentes utilizadas

Las páginas son páginas físicas del PDF. Las referencias documentan conceptos centrales; no implican adoptar toda afirmación de la fuente.

Criterio editorial

Se priorizaron recomendaciones convergentes, prudentes y aplicables. Las fuentes antiguas o especializadas se conservaron como contexto cuando requerían corroboración actual.

[R1] AAMIA_guia_abierta_para_el_cuidado.pdf

Páginas PDF: 2-3, 7. Tipo: Guía abierta.

[R2] MANUAL_BASICO_CUIDADO_PERSONAS_ADULTAS_MAYORES_16_JULIO_221021.pdf

Páginas PDF: 11, 50, 94, 123-124, 147, 160. Tipo: Manual institucional.

[R3] Manual_cuidados-generales.pdf

Páginas PDF: 10-11, 25, 28-29. Tipo: Manual práctico.

[R4] Envejecer con alegría guía para acompañar y vivir la tercera edad (Montoya Carrasquilla, Jorge).pdf

Páginas PDF: 19, 22-25. Tipo: Libro de consulta.

[R5] Cambios-fisiol-gicos-asociados-al-envejeci_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las-C.pdf

Páginas PDF: 5, 7. Tipo: Revisión clínica, 2012.

[R6] Evaluaci-n-y-cuidado-del-adulto-mayor-fr_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las-Con.pdf

Páginas PDF: 1, 4. Tipo: Revisión clínica, 2012.

[R7] Polifarmacia-y-morbilidad-en-adultos-may_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las-Con.pdf

Páginas PDF: 2, 5. Tipo: Revisión clínica, 2012.

[R8] La-gesti-n-del-paciente-mayor-con-patolog-a_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las-.pdf

Páginas PDF: 1-2. Tipo: Artículo clínico, 2012.

[R9] Evaluaci-n-de-riesgos-quir-gicos-y-manejo-post-cir_2012_Revista-M-dica-CI-n.pdf

Páginas PDF: 1, 4-5. Tipo: Revisión clínica, 2012. Nota: Contexto profesional.

[R10] Consideraciones-Del-Adulto-Mayor-En-UT_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las-Conde.pdf

Páginas PDF: 1, 4. Tipo: Artículo clínico, 2012. Nota: Contexto profesional.

[R11] Estenosis-a-rtica--Implante-de-pr-tesis-valvular-a-r_2012_Revista-M-dica-CI-.pdf

Páginas PDF: 1. Tipo: Revisión clínica, 2012. Nota: Contexto profesional.

[R12] Toma-de-decisiones-en-pacientes-con-demencia_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las.pdf

Páginas PDF: 1, 3-4. Tipo: Revisión clínica y ética, 2012.

[R13] Poblaci-n-de-80-y-m-s-a-os-en-chile--Una-visi-n-preli_2012_Revista-M-dica-CI.pdf

Páginas PDF: 1-8. Tipo: Artículo epidemiológico, 2012.

[R14] Manual de cuidado del adulto y el envejeciente II (Holguín Guzmán, Estefany Mayrobi).pdf

Páginas PDF: 19-41. Tipo: Manual académico.

Contexto editorial no indexado

Estos Markdown ayudaron a contrastar lenguaje y necesidades domésticas. No se incorporan al índice ni a la carga pública.

- Transcripción video de YouTube - Cuidado básico del adulto mayor webinar.md (enfoque integral y autonomía; no indexado).
- Artículo web- Cuidado de adultos mayores en casa- Una guía integral.md (contexto domiciliario; no indexado).

Archivos revisados y no usados como evidencia

- Editorial_2012_Revista-M-dica-CI-nica-Las-Condes.pdf: editorial general sin recomendaciones verificables para el cuidado.